

# Ruta clínica local de cervicalgia y latigazo

Ruta clínica | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

## 1. Objetivo y resultado esperado

Estandarizar evaluación de seguridad, objetivos y seguimiento sin sustituir juicio clínico ni presentar esta propuesta como GPC oficial.

## 2. Alcance y condiciones de uso

Ruta local de valoración del dolor cervical; consultar la GPC JOSPT Neck Pain Revision 2017 y revisar actualización antes de adoptar.

## 3. Responsabilidades por rol

| Rol                        | Responsabilidad                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fisioterapeuta responsable | Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.   |
| Ejecutor según proceso     | Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia. |
| Verificador o titular      | Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.      |

## 4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

## Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

### **1. Confirmar identidad, motivo, antecedentes, evolución, demandas de actividad y objetivos**

Confirmar identidad, motivo, antecedentes, evolución, demandas de actividad y objetivos. Revisar informes disponibles y mantener reserva de los datos; definir si el caso está dentro del alcance de la ruta.

### **2. Buscar alarmas: Trauma importante, signos de mielopatía, déficit progresivo, cefalea súbita**

Buscar alarmas: Trauma importante, signos de mielopatía, déficit progresivo, cefalea súbita intensa o síntomas vasculares neurológicos requieren valoración y posible remisión antes de técnicas. Registrar evidencia y conducta, evitando completar casillas de un examen no realizado.

### **3. Realizar medidas funcionales y examen pertinentes con método y unidades**

Realizar medidas funcionales y examen pertinentes con método y unidades. Distinguir dato observado, hipótesis y diagnóstico fisioterapéutico; utilizar instrumentos con versión y permisos comprobados.

### **4. Elaborar plan: Definir educación, movilidad y ejercicio según irritabilidad, funcionalidad**

Elaborar plan: Definir educación, movilidad y ejercicio según irritabilidad, funcionalidad y clasificación clínica. Evitar maniobras de alta velocidad sin evaluación, formación y consentimiento específicos; esta ruta no las autoriza. Relacionar recursos, equipo, consentimiento, carga y vigilancia con la decisión y explicar alternativas.

### **5. Reevaluar novedades antes de cada sesión, documentar actividad real y respuesta y modifica**

Reevaluar novedades antes de cada sesión, documentar actividad real y respuesta y modificar ante deterioro o falta de progreso. La disponibilidad de un equipo no constituye una indicación clínica.

### **6. Cerrar con comparación de línea base y resultados, objetivos pendientes, educación y conti**

Cerrar con comparación de línea base y resultados, objetivos pendientes, educación y continuidad. Remitir cuando el riesgo o falta de respuesta lo exige; adoptar esta ruta después de lectura completa de la fuente y adaptación documentada.

## Control, frecuencia y corrección

### 5. Verificación de la ejecución

Ruta propuesta hasta adopción documentada.

Revisar la fuente completa y nuevas recomendaciones.

Medir resultados funcionales con método consistente.

Auditar respuesta y razones de ajustes, no solo número de sesiones.

| Momento       | Comprobación y conducta                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes         | Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.  |
| Durante       | Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso. |
| Después       | Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.   |
| Ante hallazgo | Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.  |

### 6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

### 7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

### 8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

# Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Paciente y fecha            |  |
| Hipótesis y alcance         |  |
| Alarmas y conducta          |  |
| Medida inicial y método     |  |
| Objetivos                   |  |
| Intervenciones y fundamento |  |
| Dosis y respuesta           |  |
| Reevaluación                |  |
| Egreso o remisión           |  |
| Fuente adoptada y autor     |  |

## Fuentes y límites

### Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

[https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion\\_minsaludps\\_3100\\_2019.htm](https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm)

### Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

### Dolor cervical

Blanpied et al. Neck Pain: Revision 2017. JOSPT 47(7):A1-A83. DOI 10.2519/jospt.2017.0302. Consultar guía completa y actualización para su adaptación; esta ruta no reproduce la GPC.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28666405/>

Aprobó

**Eliana Milena Pardo Ríos**

TP 60576